

Praca z empatią

NPD nie ma **braku** empatii — ma **selektywną**. Empatia poznawcza zachowana (rozumienie), afektywna obniżona (współodczuwanie). Baskin-Sommers 2014: deficyt znika przy instrukcji „spróbuj poczuć”.

CZAS: 15 min Trening empatii **ŹRÓDŁO:** Ritter (2011); Baskin-Sommers (2014); Decety & Lamm (2007)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz *dwa systemy empatii* (sekcja 01): poznawczy (zachowany) i afektywny (obniżony). **2** · Zrozumiesz, dlaczego komunikat „narcyz nie ma empatii — to się nie zmieni” jest **fałszywy i szkodliwy** (sekcja 02). **3** · Wykonasz cztery ćwiczenia treningu perspektywy (sekcja 03). **4** · Poznasz *warunek skuteczności* — kiedy trening działa, a kiedy aktywuje obronę (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Brak empatii w NPD jest **selektywny**, nie totalny — pacjenci zachowują *empatię poznawczą* („wiem, co czujesz”), ale mają deficyt *empatii afektywnej* („czuję z Tobą”). Decety & Lamm (2007) rozdzielili te dwa systemy neuronalnie: poznawczy (*theory of mind*, kora przedczołowa) i afektywny (kora wyspowa, *anterior cingulate cortex*). Ritter i wsp. (2011) w metaanalizie potwierdzili tę dysocjację u pacjentów z NPD. Baskin-Sommers, Krusemark & Ronningstam (2014) w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym wykazali **najważniejsze odkrycie kliniczne**: deficyt empatii afektywnej u osób z NPD *znika* przy instrukcji „spróbuj poczuć”. To znaczy: **empatia afektywna nie jest „uszkodzonym organem”, tylko wyłączonym mechanizmem**. Mechanizm wyłączania: NPD *obronnie wyłącza* empatię afektywną — bo czucie z drugą osobą oznacza stratę grandiozyjnego self. Empatia poznawcza pozostaje aktywna, służąc do *czytania* ludzi (manipulacja, wykorzystywanie). Stąd typowy paradoks: „*wiem dokładnie, co Cię zabol* — *ale nie obchodzi mnie to*”. **Konsekwencja kliniczna**: komunikat „narcyz nie ma empatii — to się nie zmieni” jest **fałszywy i terapeutycznie szkodliwy**. Pacjent słyszy: „jestem zepsuty” → schemat defektywności wzmacnia się → dropout. Otoczenie również rezygnuje z relacji. Empatia w NPD jest *umiejętnością do treningu*, nie „brakiem organu”. Techniki: ćwiczenia perspektywy, psychodrama, listy do osób skrzywdzonych, analiza konsekwencji zachowań *dla innych*. Po 1–2 latach widoczna poprawa w skalach Interpersonal Reactivity Index (IRI, Davis 1980). **Warunek wstępny**: pacjent czuje się bezpiecznie. Wczesne wymuszanie empatii („pomyśl o partnerze”) aktywuje wstyd i obronę.

01 📋 Dwa systemy empatii — Decety & Lamm

EMPATIA POZNAWCZA

ang. *cognitive empathy / theory of mind*

Wiem, co czujesz. Rozpoznawanie emocji u innych, przewidywanie reakcji. Neuralnie: kora przedczołowa, *temporo-parietal junction*. **W NPD zachowana**, często wręcz nadrozwinęta — służy manipulacji i wykorzystywaniu.

EMPATIA AFEKTYWNA

ang. *affective empathy*

Czuję z Tobą. Współodczuwanie emocji, rezonans. Neuralnie: kora wyspowa (*insula*), *anterior cingulate cortex*. **W NPD obronnie wyłączona** — ale aktywuje się przy świadomej instrukcji.

02 ☉ Mit „brak empatii się nie zmieni”

Paradoks NPD: „wiem dokładnie, co Cię zabiło — ale nie obchodzi mnie to”. To nie psychopatia (zaburzenie antyspołeczne — tam *obie* formy empatii są obniżone). W NPD wyłączenie jest *obronne*, nie strukturalne — można je **odwrócić**.

POWSZECHNE PRZEKONANIE

„Narcyz nie ma empatii — to *biologiczne*, się nie zmieni.”
Pochodzi z *fixed mindset* i nieumiejętności rozróżnienia poznawczego/afektywnego komponentu.

PRAWDA KLINICZNA

Baskin-Sommers 2014: **deficyt znika przy instrukcji „spróbuj poczuć”**. Empatia afektywna jest *uśpiona*, nie martwa. Trenowalna — po 1-2 latach widoczna poprawa w IRI.

03 ✍ Cztery ćwiczenia treningu perspektywy

1 · PYTANIE AKTYWUJĄCE

„Jak partner/dziecko/kolega **czuł się**, gdy zrobiłem/-am X?” — nie „co myślał” (to poznawcze), tylko **czuł**. Kieruje uwagę na komponent afektywny.

2 · ODWRÓCENIE

„Gdyby **mnie** ktoś tak powiedział — jak bym się czuł/-a?” Wymusza mostek empatyczny przez własne doświadczenie. Działa, gdy wstyd jest tolerowany.

3 · LIST EMPATHII

Wybierz osobę, którą zraniłeś/-aś. Napisz *jej historię z jej perspektywy* — w pierwszej osobie. „Mam na imię... i czuję się...” Listu się *nie wysyła*.

4 · OBRAZ MENTALNY

Zamknij oczy. Wyobraź sobie siebie *jako* drugą osobę — w jej ciele, w jej historii. 5 minut dziennie. Trening *imagery* aktywuje empatię afektywną.

04 🗨 Warunek skuteczności — kolejność ma znaczenie

CO NIE DZIAŁA

„Powinieneś/-aś być bardziej empatyczny/-a.” „Pomyśl wreszcie o niej.” Moralizowanie aktywuje wstyd → obrona → wycofanie. Pacjent *nie* może być empatyczny pod przymusem.

CO DZIAŁA

Najpierw walidacja perspektywy **pacjenta**, dopiero *potem* rozszerzanie na innych. Trening po zbudowanym aliansie (zwykle po 6+ miesiącach). Łagodne pytania, nie polecenia.

Klucz: empatia w NPD jest *uśpiona*, nie martwa. Baskin-Sommers 2014: deficyt empatii afektywnej znika przy świadomej instrukcji „spróbuj poczuć”. To **dowód**, że mechanizm jest *obronny*, nie strukturalny — można go odwrócić. Trening wymaga *czasu* (1-2 lat, mierzalna poprawa w IRI Davisa 1980) i *bezpieczeństwa* (wczesne wymuszanie aktywuje wstyd i obronę). Kluczowa zasada: **walidacja perspektywy pacjenta najpierw, dopiero potem rozszerzanie na innych**. Pacjent, który nie czuje się rozumiany przez terapeutę, nie nauczy się rozumieć partnera. To nie tylko technika — to fundamentalny warunek skuteczności (Ritter 2011, Decety & Lamm 2007).